



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
HAK PASIEN DAN KELUARGA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Nomor 771.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

Tentang
Pedoman Hak Pasien dan Keluarga

Penanggung Jawab :



(Dita Pratria Permatasari)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Hak Pasien dan Keluarga dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada Sukorejo.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Hak Pasien dan Keluarga ini, mutu sumber daya manusia di Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 November 2025

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr.Aslichah, M.Kes.,AFP

PENYUSUN

1. Dita Pratria Permatasari
2. Khotimah, S.Tr.Keb
3. Ahmad Yasin, S.Pd
4. Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
5. Sisca Puspitasari, S.Kep.Ns

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

PERATURAN DIREKTUR vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 1

 1.3 Ruang Lingkup..... 2

BAB II HAK PASIEN DAN KELUARGA 3

 2.1 Hak dan Kewajiban Pasien dan Keluarga 3

 2.2 Identifikasi Hambatan 4

 2.3 Pelayanan Kerohanian..... 5

 2.4 Kerahasiaan Informasi Pasien 6

 2.5 Perlindungan Harta Benda Pasien 7

 2.6 Perlindungan Diri Pasien..... 7

 2.7 Keterlibatan Keluarga dalam Perawatan Pasien 9

 2.8 Informasi Penolakan Asuhan Medis..... 10

 2.9 Pengelolaan Nyeri dan Perawatan Akhir Hayat 10

 2.10 Manajemen Komplain 13

BAB III PROSEDUR PERSETUJUAN 15

 3.1 Persetujuan Umum (*General Consent*)..... 15

 3.2 Persetujuan Tindakan (*Informed Consent*) 15

 3.3 Pemberi Persetujuan 16

BAB IV PENUTUP 19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.9.1	Pengelolaan Hak Pasien dalam Pengkajian Nyeri	11
Tabel 2.9.2	Pengelolaan Hak Pasien dalam Penatalaksanaan Nyeri	11
Tabel 2.9.3	Pengelolaan Hak Pasien dalam Pengkajian Akhir Hayat	12
Tabel 2.9.4	Pengelolaan Hak Pasien dalam Penatalaksanaan Akhir Hayat	12
Tabel 2.10.1	Klasifikasi Derajat Komplain	13
Tabel 2.10.2	Tanggung Jawab Pengelola Komplain.....	14

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 771.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG

PEDOMAN HAK PASIEN DAN KELUARGA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO,

- Menimbang : a. bahwa hak serta kewajiban pasien dan keluarga merupakan elemen dasar dari semua interaksi di rumah sakit, staf rumah sakit, pasien dan keluarga;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 424/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Hak Pasien dan Keluarga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Hak Pasien dan Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Jendral Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Direktur Jendral Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TENTANG PEDOMAN HAK PASIEN DAN KELUARGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Pedoman Hak Pasien dan Keluarga ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang



menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

- (2) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- (3) Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (4) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- (5) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

HAK PASIEN DAN KELUARGA

Pasal 2

Hak Pasien dan Keluarga

- (1) Rumah sakit menerapkan regulasi hak pasien dan keluarga, meliputi :
 - a. Mengidentifikasi, melindungi dan mempromosikan hak – hak pasien.
 - b. Menginformasikan pasien tentang hak – hak mereka.
 - c. Melibatkan keluarga pasien, bila perlu, dalam keputusan tentang perawatan pasien.
 - d. Mendapatkan persetujuan (*informed consent*).
 - e. Mendidik staf tentang hak pasien;
- (2) Rumah sakit memiliki proses untuk mengidentifikasi siapa yang diinginkan pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatannya.
- (3) Rumah sakit memiliki proses untuk menentukan preferensi pasien, dan pada beberapa keadaan preferensi keluarga pasien, dalam menentukan informasi apa mengenai perawatan pasien yang dapat diberikan kepada keluarga/ pihak lain, dan dalam situasi apa.
- (4) Semua staf dilatih tentang proses dan peran mereka dalam mendukung hak – hak serta partisipasi pasien dan keluarga dalam perawatan.

Pasal 3

Identifikasi Hambatan

- (1) Rumah sakit mengidentifikasi hambatan serta menerapkan proses untuk mengurangi hambatan bagi pasien dalam mendapatkan akses, proses penerimaan dan pelayanan



perawatan.

- (2) Informasi terkait aspek perawatan dan tata laksana medis pasien diberikan dengan cara dan Bahasa yang dipahami pasien.
- (3) Informasi mengenai hak dan tanggung jawab pasien terpampang di area rumah sakit atau diberikan kepada setiap pasien secara tertulis atau dalam metode lain dalam bahasa yang dipahami pasien.

Pasal 4

Pelayanan Kerohanian

- (1) Staf memberikan perawatan yang penuh penghargaan dengan memerhatikan harkat dan martabat pasien.
- (2) Rumah sakit menghormati keyakinan spiritual dan budaya pasien serta nilai – nilai yang dianut pasien.
- (3) Rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien terhadap bimbingan rohani.

Pasal 5

Kerahasiaan Informasi Pasien

- (1) Rumah sakit menjamin kebutuhan privasi pasien selama perawatan dan pengobatan di rumah sakit.
- (2) Kerahasiaan informasi pasien dijaga sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Rumah sakit memiliki proses untuk meminta persetujuan pasien terkait pemberian informasi.
- (4) Rumah sakit memiliki proses untuk memberikan pasien akses terhadap informasi kesehatan mereka.

Pasal 6

Perlindungan Harta Benda Pasien

- (1) Rumah sakit menetapkan proses untuk mencatat dan melindungi pertanggung jawaban harta benda pasien.
- (2) Pasien mendapat informasi mengenai tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi harta benda pribadi.

Pasal 7

Perlindungan Diri Pasien

- (1) Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk melindungi semua pasien dari serangan fisik dan verbal.
- (2) Rumah sakit mengidentifikasi populasi yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami serangan.
- (3) Rumah sakit memantau area fasilitas yang terisolasi dan terpencil.

Pasal 8

Keterlibatan Keluarga dalam Perawatan Pasien

- (1) Rumah sakit menerapkan proses untuk mendukung pasien dan



keluarga terlibat dan berpartisipasi dalam proses perawatan dan dalam pengambilan keputusan.

- (2) Rumah sakit menerapkan proses untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi medis, diagnosis serta rencana perawatan dan terapi yang diberikan.
- (3) Pasien diberikan informasi mengenai hasil perawatan dan tata laksana yang diharapkan.
- (4) Pasien diberikan informasi mengenai kemungkinan hasil yang tidak dapat diantisipasi dari terapi dan perawatan.
- (5) Rumah sakit memfasilitasi permintaan pasien untuk mencari pendapat kedua tanpa perlu khawatir akan mempengaruhi perawatannya selama di dalam atau di luar rumah sakit.

Pasal 9

Informasi Penolakan Asuhan Medis

- (1) Rumah sakit menerapkan proses mengenai pemberian pelayanan resusitasi dan penghentian terapi penunjang kehidupan untuk pasien.
- (2) Rumah sakit memberi informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hak mereka untuk menolak atau menghentikan terapi, konsekuensi dari keputusan yang dibuat serta terapi dan alternative lain yang dapat dijadikan pilihan.

Pasal 10

Pengelolaan Nyeri dan Perawatan Akhir Hayat

- (1) Rumah sakit menerapkan proses untuk menghargai dan mendukung hak pasien mendapatkan pengkajian dan pengelolaan nyeri.
- (2) Rumah sakit menerapkan proses untuk menghargai dan mendukung hak pasien untuk mendapatkan pengkajian dan pengelolaan terhadap kebutuhan pasien menjelang akhir hayat.

Pasal 11

Manajemen Komplain

- (1) Pasien diberikan informasi mengenai proses untuk menyampaikan keluhan dan proses yang harus dilakukan pada saat terjadi konflik/ perbedaan pendapat pada proses perawatan.
- (2) Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat tersebut dikaji dan diselesaikan oleh unit/ petugas yang bertanggung jawab melalui sebuah alur/ proses spesifik.
- (3) Pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses penyelesaian keluhan, konflik dan perbedaan pendapat.

Pasal 12

Kekerasan Fisik dan Kelompok Beresiko

Rumah Sakit mempunyai untuk melakukan identifikasi populasi pasien



yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan, antara lain; bayi, lansia, ibu hamil, pasien koma, pasien dengan kelemahan fisik.

BAB III PERSETUJUAN PASIEN

Pasal 13 Persetujuan Umum (*General Consent*)

- (1) Rumah sakit menerapkan proses bagaimana persetujuan umum didokumentasikan dalam rekam medis pasien.
- (2) Pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang memerlukan *informed consent*.
- (3) Pasien menerima informasi mengenai kemungkinan keterlibatan peserta didik, mahasiswa, *residen trained* dan fellow yang berpartisipasi dalam proses perawatan.

Pasal 14 Persetujuan Tindakan (*Informed Consent*)

- (1) Rumah sakit menerapkan proses bagi pasien untuk mendapatkan *informed consent*.
- (2) Pemberian *informed consent* dilakukan oleh staf yang kompeten dan diberikan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami pasien.
- (3) Rumah sakit memiliki daftar tindakan invasif, pemeriksaan dan terapi tambahan yang memerlukan lembar persetujuan terpisah.

Pasal 15 Pemberi Persetujuan

- (1) Rumah sakit menerapkan proses untuk pemberian *informed consent* oleh orang lain selain pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rekam medis pasien mencantumkan (satu atau lebih) nama individu yang menyatakan persetujuan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 424/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Hak Pasien dan Keluarga sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17



Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO
NOMOR 771.1/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN HAK PASIEN DAN KELUARGA

PEDOMAN HAK PASIEN DAN KELUARGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kesehatan yang bermutu tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak – hak pasien dan keluarganya. Hak pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan terhadap martabat manusia, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi pasien dalam pengambilan Keputusan terkait pelayanan kesehatannya.

Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah menetapkan bahwa setiap rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak pasien dan keluarganya dalam setiap proses pelayanan Kesehatan.

Selain itu, Standar Akreditasi Rumah Sakit menekankan pentingnya penerapan prinsip *Patient and Family Rights* (Hak Pasien dan Keluarga) sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan berorientasi pada pasien. Rumah sakit harus memiliki pedoman yang jelas, terstruktur dan terdokumentasi mengenai hak pasien dan keluarga, serta memastikan seluruh tenaga Kesehatan memahami, menghormati, dan melaksanakannya dalam praktik sehari – hari.

Penyusunan Pedoman Hak Pasien dan Keluarga ini bertujuan untuk memberikan arah, acuan, dan kepastian hukum dalam penerapan hak – hak pasien dan keluarga di lingkungan rumah sakit. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada pasien, keluarga dan seluruh tenaga Kesehatan sehingga tercipta komunikasi yang efektif, partisipasi aktif pasien dan keluarga, serta perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan pasien selama menerima pelayanan Kesehatan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kepercayaan Masyarakat, serta memenuhi standar akreditasi dan regulasi yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pedoman Hak Pasien dan Keluarga ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga Kesehatan dan pihak terkait di rumah sakit dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak – hak pasien serta keluarganya selama proses pelayanan Kesehatan. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan berorientasi pada pasien.

1.2.2 Tujuan

- a. Memberikan arah dan standar dalam pelaksanaan perlindungan hak pasien dan keluarga di seluruh unit pelayanan rumah sakit.
- b. Menjamin terpenuhinya hak pasien dan keluarga, termasuk hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas privasi, hak atas keamanan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan terkait perawatan.
- c. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien melalui penerapan prinsip – prinsip etika, komunikasi efektif, serta penghargaan terhadap martabat dan otonomi pasien.
- d. Membangun hubungan yang harmonis antara pasien, keluarga dan pemberi pelayanan Kesehatan, guna mendukung proses penyembuhan, kepuasan pasien dan kepercayaan Masyarakat terhadap rumah sakit.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Hak Pasien dan Keluarga berlaku untuk seluruh kegiatan pelayanan di rumah sakit dan mencakup hal – hal sebagai berikut:

1. Penerapan hak pasien dan keluarga dalam seluruh layanan.
2. Informasi dan komunikasi hak pasien dan keluarga.
3. Hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan Keputusan.
4. Perlindungan privasi dan kerahasiaan
5. Hak atas keamanan dan kenyamanan
6. Hak atas pelayanan Kesehatan yang bermutu dan tidak diskriminatif
7. Hak atas pendampingan dan dukungan keluarga
8. Hak mengajukan keluhan dan mendapat tanggapan
9. Hak atas layanan spiritual dan kebutuhan khusus
10. Penerapan dalam semua unit dan tenaga Kesehatan.

BAB II

HAK PASIEN DAN KELUARGA

2.1 Hak Kewajiban dan Tanggungjawab Pasien dan Keluarga

2.1.1 Hak Pasien dan Keluarga

1. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur mengenai : tata tertib, hak, kewajiban dan tanggungjawab pasien
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai, Kesehatan dirinya, pelayanan Kesehatan, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang meliputi diagnosis, rencana asuhan, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya
3. Mendapatkan pelayanan Kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, efektif, anti diskriminatif, aman, bermutu sesuai dengan standart Pelayanan Kesehatan, standart profesi, dan kebutuhan medis pasien.
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, kecuali dalam rangka pencegahan penyakit menular dan KLB atau wabah.
5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat didalam rekam medis
6. Meminta konsultasi atau pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang praktek baik di Rumah Sakit yang sama atau di Rumah Sakit lain tentang penyakit yang di deritanya
7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

2.1.2 Kewajiban Pasien dan Keluarga

1. Mematuhi peraturan, tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit
3. Memberikan informasi yang jujur, lengkap serta akurat tentang data diri, riwayat penyakit, tindakan, dan obat yang pernah dikonsumsi dan masalah yang terkait dengan Kesehatan nya, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan nya tentang masalah Kesehatan nya
4. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga Kesehatan lainnya, antarlain : rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga Kesehatan Rumah Sakit yang telah disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
5. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima atau sesuai dengan Jaminan Kesehatan yang dimilikinya.

2.1.3 TanggungJawab Pasien dan Keluarga untuk :

1. Menggunakan fasilitas yang disediakan Rumah Sakit.
2. Mengajukan pertanyaan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi pengambilan Keputusan mengenai perawatan Kesehatan pasien
3. Memberikan informasi yang benar, lengkap, akurat kepada RS terakit data diri, kondisi saat ini, riwayat/masa lalu penyakit, perawatan,

tindakan, obat – obatan yang pernah diterima dan masalah yang terkait dengan Kesehatan nya.

4. Menerima konsekuensi atas Keputusan pribadinya karena menolak rencana asuhan, rencana terapi, instruksi perawatan yang direkomendasikan oleh tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga Kesehatan
5. Menanggung semua risiko yang ditimbulkan atas pilihan, ketidakpatuhan terhadap tata tertib, kegiatan penanggulangan KLB/wabah dan semua peraturan yang berlaku di RS
6. Bekerjasama dengan tenaga Kesehatan yang terlibat dalam perawatan
7. Menghormati hak penyedia layanan Kesehatan dan bertukar informasi dengan cara yang tidak kasar baik secara fisik maupun lisan saat menerima perawatan
8. Berdiskusi tentang masalah perawatan kesehatan, kekhawatiran, dan kebutuhan pribadi dengan penyedia layanan kesehatan secara jujur dan untuk menginformasikan kepada penyedia layanan Kesehatan tentang setiap perubahan kondisi yang terjadi
9. Menepati semua janji pertemuan yang dijadwalkan untuk memastikan bahwa semua pasien dilayani tepat waktu
10. Pasien bertanggung jawab untuk memberitahu 24 jam sebelum nya jika ada perubahan jadwal
11. Menghormati hak semua profesional perawatan Kesehatan, karyawan, dan pasien lain
12. Membayar jasa layanan yang telah diterima
13. Memberitahu penyedia layanan Kesehatan terhadap perubahan Keputusan mengenai orang yang ditunjuk dalam membuat keputusan perawatan kesehatan.

2.1.4 Identifikasi penetapan pihak yang diijinkan pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan perawatan

1. Identifikasi pasien
 - a. Pastikan pasien dalam kondisi sadar, kompeten, dan mampu mengambil Keputusan.
 - b. Jika pasien mampu, ia menetapkan sendiri pihak yang diizinkan berpartisipasi.
 - c. Jika pasien tidak mampu (tidak sadar, anak – anak, gangguan mental), maka pihak yang berhak ditetapkan sesuai urutan prioritas keluarga atau wali hukum.
2. Kriteria pihak yang diijinkan
 - a. Berusia ≥ 18 tahun atau sudah menikah
 - b. Mampu secara hukum (tidak ada status gangguan jiwa/ terbata hukum)
 - c. Memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan pasien, biasanya dalam urutan :
 - 1) Suami/istri
 - 2) Anak kandung/dewasa
 - 3) Orang tua kandung
 - 4) Saudara kandung
 - 5) Keluarga terdekat lain atau pihak yang diberi kuasa tertulis
 - d. Jika pasien tidak memiliki keluarga, wali hukum/ pengampu yang sah dapat ditunjuk
3. Proses penetapan
 - a. Bila pasien kompeten

- 1) Pasien menyatakan secara tertulis atau lisan siapa pihak yang diizinkan ikut dalam pengambilan Keputusan.
- 2) Rumah sakit menyediakan formulir persetujuan/ kuasa untuk dokumentasi
- b. Bila pasien tidak kompeten
 - 1) Rumah sakit melakukan verifikasi identitas keluarga yang hadir sesuai prioritas hukum
 - 2) Pencatatan dalam rekam medis siapa yang menjadi pengambil Keputusan

2.2 Identifikasi Hambatan

1. Identifikasi Awal (saat pendaftaran/admisi)
 - a. Petugas melakukan wawancara singkat dengan pasien/ keluarga mengenai :
 - 1) Hambatan bahasa atau komunikasi (misalnya pasien tidak memahami bahasa Indonesia).
 - 2) Hambatan fisik (pasien disabilitas, lansia atau kesulitan mobilisasi).
 - 3) Hambatan budaya atau social (keyakinan tertentu yang mempengaruhi penerimaan pelayanan).
 - 4) Hambatan psikologis (pasien cemas atau takut menerima perawatan)
 - 5) Hambatan administrative (misalnya kesulitan proses pendaftaran atau persyaratan jaminan)
 - 6) Hambatan literasi Kesehatan (ketidam mampuan memahami informasi medis)
 - b. Hasil identifikasi dicatat dalam formulir pendaftaran atau rekam medis elektronik.
 - c. Jika ditemukan hambatan, petugas memberikan tanda atau catatan khusus pada rekam medis untuk ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terkait.
2. Identifikasi lanjutan (selama perawatan)
 - a. Staf klinis melakukan pengkajian ulang terhadap kemungkinan hambatan baru yang muncul selama proses perawatan (misalnya kesulitan memahami instruksi pengobatan, hambatan komunikasi dengan tenaga medis).
 - b. Hasil pengkajian dicatat dalam rekam medis pasien.
3. Penetapan tindakan mengatasi hambatan
 - a. Petugas/ unit terkait Menyusun tindakan untuk mengurangi hambatan, misalnya :
 - 1) Penyediaan penerjemah atau tenaga yang menguasai bahasa pasien.
 - 2) Penyediaan brosur atau media informasi dalam bahasa yang dipahami pasien.
 - 3) Penggunaan alat bantu dengar, kursi roda atau panduan visual
 - 4) Pendampingan oleh keluarga.
 - b. Tindakan dicatat dalam rekam medis
4. Tindak lanjut dan monitoring
 - a. Penempatan informasi hak dan tanggung jawab pasien di area yang mudah terlihat.
 - b. Penyediaan materi dalam bentuk cetak atau digital yang dapat dibawa pasien.

- c. Penyuluhan atau penjelasan langsung oleh petugas admisi atau perawat saat penerimaan pasien.
- d. Evaluasi pemahaman pasien secara berkala (misalnya melalui pertanyaan balik atau formulir).
- e. Tindak lanjut terhadap hambatan yang ditemukan, misalnya dengan mencatat dalam rekam medis dan melaporkan ke unit terkait untuk perbaikan system pelayanan.

2.3 Pelayanan Kerohanian

1. Identifikasi kebutuhan kerohanian
 - a. Petugas admisi atau perawat melakukan identifikasi agama/kepercayaan pasien saat awal masuk
 - b. Perawat mencatat kebutuhan khusus kerohanian di rekam medis (misalnya permintaan bimbingan Rohani, ibadah rutin atau ritual tertentu)
 - c. Bila pasien tidak mampu menyampaikan, keluarga dapat memberikan informasi.
2. Penghormatan nilai spiritual dan budaya
 - a. Staf klinis memberikan pelayanan dengan penuh penghargaan terhadap harkat dan martabat pasien, termasuk keyakinan spiritual dan budaya.
 - b. Tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai spiritual pasien kecuali dalam keadaan gawat darurat medis dan dengan penjelasan yang dapat dipahami pasien atau keluarga.
3. Pelayanan dan fasilitas bimbingan Rohani
 - a. Rumah sakit menyediakan sarana ibadah yang mudah diakses.
 - b. Bila pasien membutuhkan pelayanan Rohani:
 - 1) Perawat atau petugas menghubungi rohaniawan internal rumah sakit.
 - 2) Bila tidak tersedia, rumah sakit dapat mengizinkan rohaniawan dari luar sesuai agama pasien dengan mengikuti prosedur keamanan dan kerahasiaan pasien.
 - c. Pelayanan dilakukan dengan menjaga privasi, ketenangan lingkungan dan tidak mengganggu pasien lain.
4. Pendokumentasian
 - a. Semua permintaan dan pelaksanaan pelayanan kerohanian dicatat dalam rekam medis pasien.
 - b. Bila pasien menolak pelayanan Rohani, penolakan tersebut juga dicatat.
5. Tindak lanjut dan evaluasi
 - a. Unit keperawatan dan pelayanan kerohanian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan Rohani secara berkala.
 - b. Rumah sakit melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan survei kepuasan pasien.

2.4 Kerahasiaan Informasi Pasien

1. Pengumpulan dan penyimpanan informasi
 - a. Informasi pasien dikumpulkan dan dicatat hanya oleh petugas yang berwenang.
 - b. Rekam medis disimpan di tempat aman dengan pengaturan akses terbatas.
 - c. Data elektronik pasien dilindungi dengan system password dan kontrol akses.
2. Akses informasi

- a. Akses terhadap rekam medis atau data pasien hanya diberikan kepada:
 - 1) Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien.
 - 2) Pihak manajemen rumah sakit untuk keperluan operasional.
 - 3) Peneliti yang telah mendapat persetujuan etik dan izin tertulis.
 - b. Setiap permintaan informasi oleh pihak luar (asuransi, pengacara, pihak ketiga) harus dilengkapi dengan persetujuan pasien/ keluarga.
3. Pemberian informasi kepada pihak ketiga
- a. Informasi dapat diberikan kepada pihak ketiga hanya bila:
 - 1) Ada persetujuan tertulis dari pasien/ keluarga
 - 2) Ada kewajiban hukum
 - 3) Dalam kondisi gawat darurat yang mengancam keselamatan pasien atau Masyarakat.
 - b. Setiap pemberian informasi dicatat dalam formulir komunikasi/ edukasi.
4. Komunikasi internal
- a. Diskusi mengenai kondisi pasien hanya dilakukan di area tertutup dan dengan petugas yang berwenang.
 - b. Penggunaan media social untuk membicarakan pasien dilarang keras.
 - c. Dokumen yang berisi informasi pasien tidak boleh dibiarkan terbuka ditempat umum.
5. Pemusnahan informasi
- a. Dokumen pasien yang sudah melewati masa retensi akan dimusnahkan dengan prosedur resmi.
 - b. Proses pemusnahan harus disertai berita acara.

2.5 Perlindungan Harta Benda Pasien

1. Penerimaan barang pasien
- a. Saat pasien masuk (IGD), petugas melakukan inventarisasi barang bawaan, terutama barang berharga (perhiasan, uang, alat elektronik, dokumen penting)
 - b. Pasien/ keluarga diberi penjelasan tentang kebijakan rumah sakit jika tidak dianjurkan untuk membawa barang berharga (perhiasan, uang, alat elektronik)
2. Penyimpanan barang titipan
- a. Barang berharga pasien yang dititipkan dimasukkan ke dalam lemari khusus dan diberi label identitas pasien.
 - b. Barang yang dititipkan ditulis dibuku penitipan barang (jenis barang dan jumlah barang) kemudian di tanda tangani oleh security dan saksi (penanggung jawab shift atau Kepala Ruang IGD)
3. Pengambilan barang
- a. Barang hanya dapat diambil oleh pasien/keluarga dengan menunjukkan identitas yang sesuai
 - b. Petugas mencatat tanggal dan tanda tangan penerima pada buku penitipan barang
4. Penanganan kehilangan/ kerusakan barang
- a. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, pasien/keluarga segera melapor ke perawat atau keamanan.
 - b. Petugas membuat berita acara kehilangan dan melaporkan ke bagian keamanan dan manajemen rumah sakit.
 - c. Dilakukan investigasi internal sesuai prosedur dan jika terbukti kelalaian rumah sakit, diberikan kompensasi sesuai kebijakan.

2.6 Perlindungan Diri Pasien

1. Pengembangan dan penerapan proses perlindungan

a. Penyusunan regulasi dan SOP perlindungan pasien dari kekerasan fisik dan verbal, termasuk:

1) Larangan tindakan kekerasan terhadap pasien.

2) Prosedur pelaporan dan penanganan kejadian kekerasan

a) Tahap 1 – Deteksi dan respon cepat

(1) Petugas yang menyaksikan/ menjadi korban kekerasan

- Menenangkan pasien/korban
- Aktifkan “Kode Kekerasan”/ panggil tim keamanan melalui alat komunikasi yang tersedia
- Amankan area sekitar agar tidak meluas

(2) Tim keamanan segera datang ke Lokasi dan mengamankan pelaku serta melindungi korban

b) Tahap 2 – Pelaporan awal

(1) Petugas yang menyaksikan/ korban mengisi formulir pelaporan kejadian kekerasan mencakup:

- Waktu, tempat, kronologi singkat
- Identitas korban dan pelaku (jika diketahui)
- Jenis kekerasan (fisik/verbal)

(2) Laporan diserahkan ke kepala unit dan PMKP

(3) Bila kejadian berat (mengancam nyawa), segera lapor ke pimpinan rumah sakit dan bila perlu pihak kepolisian

c) Tahap 3 – Penanganan korban dan situasi

(1) Korban pasien → diberi pertolongan medis dan psikologis sesuai kebutuhan.

(2) Korban petugas/ pengunjung → diarahkan ke IGD untuk perawatan dan konseling

(3) Pelaku → diamankan, diidentifikasi dan ditangani sesuai ketentuan (termasuk koordinasi dengan pihak berwenang jika criminal)

(4) Unit terkait menstabilkan kondisi pelayanan agar tetap berjalan aman.

d) Tahap 4 – Dokumentasi dan Investigasi (≤ 1x24 jam)

(1) Tim PKMP/ MFK mencatat laporan dalam system pelaporan insiden rumah sakit.

(2) Dilakukan investigasi awal untuk mengidentifikasi penyebab dan kategori insiden

(3) Bila perlu, lakukan Analisa akar masalah jika insiden berdampak besar

e) Tahap 5 – Tindak lanjut dan pelaporan resmi

(1) Tim mutu Menyusun rekomendasi perbaikan system/ pelayanan dan melaporkannya kepada Direktur rumah sakit

- (2) Hasil tindaklanjut didokumentasikan sebagai bagian dari evaluasi mutu dan keselamatan pasien
 - (3) Bila pelaku Adalah tenaga internal Rumah Sakit, dilakukan pembinaan atau tindakan disiplin sesuai regulasi kepegawaian.
 - (4) Bila pelaku eksternal, dilakukan pendekatan hukum bila diperlukan
 - b. Sosialisasi dan pelatihan kepada semua staf tentang deteksi dini, teknik komunikasi efektif dan pencegahan kekerasan
 - c. Pelaksanaan perlindungan di lapangan, meliputi:
 - 1) Pengawasan oleh staf keamanan di area rawan
 - 2) Respons cepat terhadap insiden kekerasan fisik/ verbal.
 - 3) Penggunaan system pelaporan insiden keselamatan pasien.
 - d. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan perlindungan pasien.
2. Identifikasi populasi risiko tinggi
- a. Menetapkan kriteria populasi risiko tinggi, antara lain:
 - 1) Bayi dan anak – anak
 - 2) Pasien lanjut usia
 - 3) Pasien dengan gangguan mental atau fisik berat
 - 4) Pasien dengan status isolasi atau tidak mampu membela diri
 - b. Pencatatan dan penandaan populasi risiko tinggi dalam rekam medis dan system informasi rumah sakit
 - c. Peningkatan kewaspadaan staf terhadap pasien risiko tinggi melalui briefing, visit dan supervisi rutin.
 - d. Pemberlakuan pengawasan ekstra dan pembatasan pengunjung di area populasi risiko tinggi
3. Pemantauan area fasilitas terpencil dan terisolasi
- a. Melakukan penilaian area yang tergolong terpencil atau terisolasi (misalnya ruang isolasi, Lorong jauh)
 - b. Meningkatkan keamanan area tersebut dengan langkah berikut:
 - 1) CCTV aktif dan pemantauan terpusat
 - 2) Penerangan yang cukup
 - 3) Akses pengunjung terbatas dengan identitas jelas
 - 4) Jadwal patrol keamanan rutin
 - 5) Penempatan staf jaga di area berisiko
 - c. Pembuatan laporan pengawasan rutin dan tim keamanan dan unit terkait kepada manajemen

2.7 Keterlibatan Keluarga dalam Perawatan Pasien

- 1. Keterlibatan dalam pengambilan Keputusan perawatan
 - a. Keluarga dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan Keputusan medis, termasuk pemilihan tindakan, prosedur dan rencana terapi.
 - b. Rumah sakit menyediakan waktu dan ruang untuk berdiskusi dengan keluarga tentang kondisi pasien dan pilihan terapi yang tersedia.
 - c. Keluarga diberikan kesempatan untuk bertanya, mempertimbangkan dan memberikan persetujuan (*informed consent*) bersama pasien, terutama bila pasien tidak dapat mengambil Keputusan sendiri.
- 2. Keterlibatan dalam proses edukasi kondisi dan terapi

- a. Keluarga menerima edukasi tentang kondisi medis pasien, diagnosa, hasil pemeriksaan serta rencana terapi atau tindakan yang akan dilakukan.
 - b. Edukasi diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dicatat dalam rekam medis atau formulir edukasi.
 - c. Keluarga dapat menyatakan pemahamannya dan memberikan masukan terhadap rencana perawatan.
3. Keterlibatan dalam pemberian persetujuan tindakan (*Informed Consent*)
- a. Keluarga memberikan persetujuan tindakan kedokteran bila pasien tidak dapat memberikan persetujuan sendiri (misalnya karena tidak sadar, anak – anak, atau pasien dengan gangguan kognitif).
 - b. Formulir *informed consent* ditandatangani oleh keluarga/ wali sah, dengan penjelasan lengkap dari tenaga Kesehatan.
 - c. Keluarga dapat memilih untuk menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut sebelum menandatangani.
4. Keterlibatan dalam penyusunan dan penyesuaian rencana perawatan
- a. Keluarga ikut serta dalam penyusunan rencana perawatan, terutama untuk pasien dengan kondisi kronis, terminal atau membutuhkan perawatan jangka Panjang.
 - b. Tenaga Kesehatan memberikan alternatif dan konsekuensi dari setiap rencana, lalu keluarga bersama pasien membuat Keputusan akhir.
 - c. Keluarga berperan dalam menyampaikan preferensi atau nilai – nilai pasien yang mungkin tidak dapat disampaikan sendiri.
5. Keterlibatan dalam perencanaan pulang dan perawatan lanjutan
- a. Keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan pulang pasien, termasuk edukasi mengenai terapi lanjutan, obat – obatan, kontrol ulang, serta tanda bahaya yang harus diwaspadai.
 - b. Rumah sakit memberikan informasi tertulis maupun lisan kepada keluarga untuk memastikan kesinambungan perawatan di rumah.
 - c. Keluarga berperan aktif dalam mendukung kepatuhan pengobatan dan pemantauan kondisi pasien setelah pulang.

2.8 Informasi Penolakan Asuhan Medis

1. Pemberian informasi medis
- a. DPJP memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien dan/atau keluarga mengenai:
 - 1) Kondisi medis pasien
 - 2) Rencana terapi atau tindakan yang akan dilakukan
 - 3) Tujuan dan manfaat tindakan
 - 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin timbul
 - 5) Alternatif terapi yang tersedia
 - 6) Konsekuensi bila terapi ditolak
 - b. Informasi diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami
 - c. Tenaga Kesehatan memberikan kesempatan kepada pasien/ keluarga untuk bertanya dan mempertimbangkan keputusan
2. Penolakan informasi medis oleh pasien/ keluarga
- a. Bila pasien atau keluarga menolak menerima informasi medis:
 - 1) Petugas mencatat penolakan tersebut dalam rekam medis
 - 2) Penolakan dituangkan dalam formulir penolakan penerimaan informasi medis yang ditanda tangani oleh pasien/ keluarga, DPJP dan saksi.

- b. DPJP tetap menyampaikan informasi minimal yang wajib diketahui untuk keselamatan pasien, mislanya mengenai risiko langsung atau tindakan emergensi.
- c. Bila pasien tidak kompeten secara hukum atau klinis, maka Keputusan penolakan dapat dilakukan oleh wali sah atau keluarga terdekat sesuai ketentuan perundangan.

2.9 Pengelolaan Nyeri dan Perawatan Akhir Hayat

- 1. Hak pasien dalam pengkajian dan pengelolan nyeri
 - a. Hak pasien yang terkait
 - 1) Pasien berhak memperoleh pengkajian yang komprehensif, termasuk nyeri, sejak awal masuk dan selama proses perawatan.
 - 2) Pasien berhak mendapatkan pengelolaan nyeri yang efektif, manusiawi dan sesuai kebutuhan klinis
 - 3) Pasien berhak menyampaikan keluhan nyeri secara terbuka dan mendapatkan respons segera dari tenaga Kesehatan.
 - 4) Pasien dan keluarga berhak mendapatkan informasi tentang rencana penatalaksanaan nyeri, efek smaping dan pilihan terapi yang tersedia.
 - 5) Pasien berhak berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan mengenai pengelolaan nyeri, termasuk penolakan atau penerimaan terapi.
 - 6) Pasien berhak mendapatkan penghormatan terhadap keyakinan dan nilai pribadi dalam proses pengelolaan nyeri, termasuk pada perawatan akhir hayat.
 - b. Pengelolaan hak pasien dalam pengkajian nyeri

Tabel 2.9.1 Pengelolaan Hak Pasien dalam Pengkajian Nyeri

No	Langkah	Tindakan Rumah Sakit/ Tenaga Kesehatan
1	Pengkajian awal	Lakukan pengkajian nyeri pada smeua pasien saat masuk, menggunakan instrument standar
2	Pengkajian berkelanjutan	Evaluasi nyeri secara rutin selama perawatan dan setelah tindakan medis/ keperawatan
3	Pelibatan pasien	Libatkan pasien dan keluarga dalam menggambarkan intensitas, Lokasi dan karekteristik nyeri
4	Dokuemntasi	Catat semua hasil pengkajian nyeri secara akurat dan lengkap dalam rekam medis

- c. Pengelolaan hak pasien dalam penatalaksanaan nyeri

Tabel 2.9.2 Pengelolan Hak Pasien dalam Penatalaksanaan Nyeri

No	Langkah	Tindakan Rumah Sakit/ Tenaga Kesehatan
1	Penentuan rencana terapi	Susun rencana penatalaksanaan nyeri yang disesuaikan dengan hasil pengkajian, kondisi klinis dan preferensi pasien
2	Pemberian terapi	Berikan intervensi nyeri farmakologis (analgetic, sedative) dan non-farmakologis (kompres hangat/dingin, distraksi, Teknik relaksasi, dsb) sesuai indikasi.
3	Edukasi	Berikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai tujuan pengelolaan nyeri, efek samping dan cara melaporkan nyeri
4	Evaluasi efektivitas	Lakukan evaluasi ulang setelah tindakan untuk menilai efektivitas penanganan nyeri dan sesuaikan rencana bila perlu

5	Hormati kepuasan pasien	Jika pasien menolak tindakan tertentu, rumah sakit wajib memberikan penjelasan risiko dan alternatif terapi, lalu mendokumentasikannya
---	-------------------------	--

- d. Pengelolaan nyeri pada perawatan akhir hayat
 - 1) Rumah sakit mengidentifikasi kebutuhan nyeri dan kenyamanan pasien menjelang akhir hayat, termasuk aspek spiritual, social dan psikologis
 - 2) Fokus utama Adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, bukan semata memperpanjang usia biologis
 - 3) Pasien berhak memperoleh:
 - a) Pengkajian kebutuhan nyeri dan kenyamanan akhir hayat
 - b) Terapi paliatif dan suportif sesuai kondisi
 - c) Penghormatan terhadap Keputusan pasien/ keluarga terkait jenis perawatan yang diberikan atau dihentikan.
- 2. Hak dalam pengkajian dan pengelolaan terhadap kebutuhan pasien menjelang akhir hayat

- a. Hak pasien yang terkait
 - 1) Hak untuk mendapatkan perawatan yang bermartabat, manusiawi dan menghargai nilai serta keyakinan pasien dan keluarga.
 - 2) Hak untuk memperoleh pengkajian menyeluruh terhadap kebutuhan fisik, psikologis, social, spiritual dan budaya
 - 3) Hak untuk mendapatkan kenyamanan dan pengelolaan nyeri yang optimal, bukan semata – mata upaya memperpanjang kehidupan secara medis.
 - 4) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi, pilihan perawatan, serta risiko dan manfaat dari tindakan medis.
 - 5) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan mengenai jenis dan Batasan perawatan yang diterima.
 - 6) Hak untuk didampingi keluarga dan memperoleh dukungan emosional serta spiritual yang sesuai.
 - 7) Hak untuk menolak atau menerima tindakan medis tertentu dengan *informed consent* yang sah.
 - 8) Hak untuk mendapatkan dukungan tim paliatif atau layanan perawatan akhir hayat sesuai standar.
- b. Pengelolaan hak pasien dalam pengkajian kebutuhan menjelang akhir hayat

Tabel 2.9.3 Pengelolaan Hak Pasien dalam Pengkajian Akhir Hayat

No	Langkah	Tindakan Rumah Sakit/ Tenaga Kesehatan
1	Identifikasi fase akhir hayat	DPJP melakukan penilaian medis untuk menentukan bahwa pasien berada dalam kondisi terminal atau tidak responsive terhadap terapi kuratif
2	Pengkajian komprehensif	Tim Kesehatan melakukan pengkajian multidimensi (fisik, psikologis, social, spiritual, budaya serta preferensi pasien dan keluarga)
3	Pelibatan pasien dan keluarga	Libatkan pasien dan keluarga dalam menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka
4	Dokumentasi	Hasil pengkajian dicatat secara lengkap dalam rekam

		medis sebagai dasar penyusunan rencana perawatan akhir hayat.
--	--	---

c. Pengelolaan hak pasein dalam penatalaksanaan kebutuhan akhir hayat

Tabel 2.9.4 Pengelolaan Hak Pasien dalam Penatalaksanaan Kebutuhan Akhir Hayat

No	Langkah	Tindakan Rumah Sakit/ Tenaga Kesehatan
1	Rencana perawatan individu	Susun rencana perawatan yang focus pada kenyamanan, mengurangi penderitaan dan menghargai nilai pasien
2	Pengelolaan nyeri dan gejala	Berikan penatalaksanaan nyeri dan gejala terminal secara efektif dan etis
3	Dukungan emosional dan spiritual	Libatkan rohaniawan, konselor atau perwakilan agama sesuai permintaan pasien/keluarga
4	Komunikasi terbuka	Tim Kesehatan memberikan informasi berkala tentang kondisi pasien dan menjawab keluarga secara empatik
5	Keputusan medis dan hukum	Fasilitasi proses <i>informed consent</i> atau penolakan tindakan bila sesuai dengan kondisi.
6	Dukungan keluarga	Rumah sakit memberi kesempatan keluarga untuk menemani, memberi waktu berpamitan dan mendampingi pasien di ruang perawatan.

2.10 Manajemen Komplain

1. Klasifikasi derajat complain

Tabel 2.10.1 Klasifikasi Derajat Komplain

Warna	Derajat/ karakteristik	Contoh Komplain	Penanggung Jawab Penanganan	Waktu Tindak Lanjut	Bentuk Penyelesaian
Hijau	Derajat I Komplain ringan, tidak berdampak klinis, dapat diselesaikan langsung di unit	Waktu tunggu lama, pelayanan lambat, informasi kurang jelas	Petugas/ Kepala Unit/ Koordinator Unit	1x24 jam	Penjelasan langsung, klarifikasi perbaikan cepat
Kuning	Derajat II Komplain sedang, berdampak pada kepuasan atau proses pelayanan, memerlukan klarifikasi lintas unit	Sikap petugas tidak sopan, ketidakjelasan prosedur, pelayanan tidak sesuai standar	Kepala unit/ MOD/ Penanggung jawab pelayanan	3x24 jam	Klarifikasi, pertemuan, tindak lanjut lintas unit, jawaban tertulis/ lisan
Merah	Derajat III Komplain berat, berdampak luas atau	Dugaan malpraktik, kerugian besar, keluhan ke media,	MOD/ Direksi/ Bagian Hukum/ Tim Mutu	7x24 jam	Investigasi, RCA, rapat manajemen, jawaban resmi tertulis,

	berpotensi hukum, menyangkut keselamatan pasien atau reputasi rumah sakit	ancaman hukum			rekomendasi perbaikan sistemik
--	---	---------------	--	--	--------------------------------

2. Alur penanganan komplain
 - a. Penerimaan komplain
 - 1) Terima semua bentuk complain (lisan, tertulis, media, elektronik)
 - 2) Sambut dengan sikap empatik dan sopan
 - 3) Catat dalam formulir komplain
 - b. Klasifikasi komplain
 - 1) Tentukan Tingkat komplain berdasarkan derajat dampak dan urgensi
 - 2) Rujuk komplain ke penanggung jawab sesuai tingkatnya
 - c. Tindak lanjut komplain
 - 1) Tingkat I → tindak lanjut langsung oleh petugas/ unit dan konfirmasi kepuasan
 - 2) Tingkat II → lakukan klarifikasi lintas unit dan selesaikan oleh kepala unit/ MOD
 - 3) Tingkat III → eskalasi ke MOD/ Manajemen, lakukan investigasi dan Analisa akar masalah (RCA)
 - d. Penyelesaian dan komunikasi
 - 1) Berikan jawaban kepada pengadu secara lisan atau tertulis sesuai derajat komplain
 - 2) Pastikan pengadu memahami Solusi yang diberikan
 - e. Dokumentasi dan evaluasi
 - 1) Dokumentasi seluruh proses dan hasil penanganan komplain
 - 2) Rekap dan analisis tren keluhan secara berkala untuk tindakan perbaikan

3. Tanggung jawab

Tabel 2.10.2 Tanggung Jawab Pengelola Komplain

No	Pihak	Tanggung Jawab
1	Petugas lini depan	Menerima, mencatat, menangani komplain ringan
2	Kepala unit/ koordinator	Menangani komplain Tingkat II, koordinator Tingkat lanjut lintas unit
3	MOD/ Tim Mutu	Menangani komplain Tingkat III, investigasi, monitoring, evaluasi
4	Humas/ MOD	Menyampaikan jawaban resmi ke public/ pengadu bila perlu
5	Manajemen RS	Menetapkan Keputusan akhir dan kebijakan perbaikan sistemik

4. Pelaporan dan evaluasi
 - a. Rekap komplain dilakukan minimal 1 kali per bulan oleh Tim Mutu/ MOD
 - b. Analisis tren komplain per unit, jenis dan derajat untuk perbaikan mutu
 - c. Laporkan hasilnya dalam rapat manajemen mutu
 - d. Gunakan data keluhan untuk perbaikan SOP, pelatihan atau perubahan system.

BAB III

PROSEDUR PERSETUJUAN

3.1 Persetujuan Umum (General Consent)

1. Ketentuan Umum

- a. Rumah sakit wajib memperoleh persetujuan umum dari setiap pasien atau keluarganya pada saat pertamakali datang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.
- b. Persetujuan umum diberikan dalam bentuk tanda tangan formulir general consent sebagai bagian wajib dari berkas rekam medis pasien.
- c. Staf admisi wajib memberikan penjelasan mengenai isi formulir persetujuan umum secara lisan dan tertulis.
- d. Dokumen persetujuan umum disimpan dalam rekam medis pasien sebagai bukti legal dan administrative.

2. Prosedur

a. Persiapan

- 1) Staf admisi menyipakan formulir persetujuan umum yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.
- 2) Formulir harus mencakup penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien, jenis pelayanan, serta persetujuan terhadap prosedur umum pelayanan.

b. Pemberian informasi

- 1) Staf admisi atau petugas pendaftaran memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarga mengenai isi formulir persetujuan umum dengan bahasa yang mudah dipahami.
- 2) Pasien diberi kesempatan untuk bertanya sebelum menandatangani formulir.

c. Pemberian persetujuan

- 1) Pasien/ keluarga menandatangani formulir persetujuan umum sebagai bentuk kesediaan menerima pelayanan Kesehatan sesuai prosedur rumah sakit.
- 2) Bila pasien tidak dapat menandatangani, maka persetujuan dapat diberikan oleh wali atau keluarga terdekat sesuai ketentuan hukum

d. Dokumentasi

- 1) Formulir yang telah ditandatangani sebagai bagian dalam rekam medis pasien
- 2) Staf admisi memverifikasi bahwa persetujuan umum telah diperoleh.

e. Monitoring dan evaluasi

- 1) Unit rekam medis bersama unit mutu melakukan audit berkala terhadap kelengkapan dokumen persetujuan umum.
- 2) Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit untuk perbaikan berkelanjutan.

3.2 Persetujuan Tindakan (*Informed Consent*)

1. Ketentuan umum

- a. Rumah sakit memperoleh informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) secara tertulis dari pasien atau keluarga sebelum tindakan dilakukan.

- b. Penjelasan tindakan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau tenaga Kesehatan yang berwenang, bukan oleh petugas administrasi.
- c. Persetujuan diberikan secara sadar, tanpa paksaan, setelah pasien/ keluarga memahami informasi yang disampaikan.
- d. Formulir *informed consent* menjadi bagian dari rekam medis.

2. Prosedur

a. Persiapan

- 1) Dokter/ tenaga Kesehatan memastikan bahwa tindakan medis yang akan dilakukan memerlukan *informed consent* sesuai kategori (misalnya tindakan operatif, invasive, berisiko tinggi atau terapi khusus).
- 2) Menyiapkan formulir *informed consent* sesuai format rumah sakit.

b. Pemberian informasi

Dokter/ DPJP wajib memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarga mencakup:

- 1) Diagnosis dan indikasi yang akan dilakukan.
- 2) Tujuan tindakan yang akan dilakukan
- 3) Prosedur dan tahapan tindakan.
- 4) Risiko, komplikasi dan efek samping yang mungkin timbul
- 5) Alternatif tindakan dan kemungkinan hasil jika tidak dilakukan.
- 6) Prognosis dan rencana lanjutan

c. Pemberian persetujuan

- 1) Setelah informasi diterima dan dipahami, pasien atau keluarga/ wali menandatangani formulir *informed consent*.
- 2) Bila pasien tidak mampu memberikan persetujuan, maka dilakukan oleh keluarga terdekat atau wali sah sesuai hukum.
- 3) Dalam keadaan gawat darurat yang mengancam nyawa dan tidak memungkinkan persetujuan segera diperoleh, tindakan dapat dilakukan sesuai indikasi medis dengan dokumentasi yang jelas.

d. Dokumentasi

- 1) Formulir *informed consent* yang telah ditanda tangani harus dimasukkan ke dalam rekam medis pasien.
- 2) Catatan pemberian informasi dicatat oleh dokter dalam rekam medis, termasuk waktu, nama pemberi informasi dan pihak yang menerima.

e. Monitoring dan evaluasi

- 1) Unit rekam medis dan mutu melakukan audit berkala terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen *informed consent*.
- 2) Hasil audit dilaporkan kepada Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

3.3 Pemberi Persetujuan

1. Persyaratan Pemberi Persetujuan Medis

a. Pasien yang cakap hukum

- 1) Pasien dewasa (≥ 18 tahun) dan/atau sudah menikah yang dalam kondisi sadar dan kompeten secara hukum dapat memberikan persetujuan sendiri terhadap tindakan kedokteran.

b. Pihak lain yang sah secara hukum, apabila pasien tidak mampu menyatakan persetujuan, yaitu:

- 1) Keluarga terdekat, meliputi:
 - a) Suami atau istri

- b) Anak kandung (dewasa dan kompeten hukum)
 - c) Orang tua kandung
 - d) Saudara kandung (dewasa dan kompeten hukum)
 - 2) Wali yang sah
 - a) Orang atau Lembaga yang secara hukum ditunjuk untuk mewakili pasien (misalnya wali anak atau pasien dengan disabilitas mental)
 - b) Dibuktikan dengan surat penetapan atau dokumen resmi yang sah
 - 3) Kuasa yang sah
 - a) Individu yang diberikan surat kuasa resmi oleh pasien untuk mengambil Keputusan medis.
- c. Ketentuan tambahan sesuai peraturan
Proses pemberian persetujuan oleh pihak lain harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, terutama dalam hal:
 - 1) Pasien tidak sadar atau tidak mampu secara hukum menyatakan persetujuan
 - 2) Tidak terdapat keluarga yang dapat memberikan persetujuan
 - 3) Dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa, tindakan dapat dilakukan segera dengan dokumentasi Keputusan medis oleh dokter penanggung jawab.
- 2. Seseorang yang tidak diperbolehkan memberikan persetujuan tindakan medis
 - a. Pasien yang tidak cakap hukum
Yaitu pasien yang secara hukum tidak dapat membuat Keputusan sendiri, misalnya:
 - 1) Pasien dibawah umur (belum berusia 18 tahun dan belum menikah)
 - 2) Pasien dalam kondisi tidak sadar, tidak mampu berkomunikasi atau mengalami gangguan mental berat yang membuatnya tidak mampu memahami informasi medis.
 - 3) Pasien yang dinyatakan tidak kompeten secara hukum (misalnya berdasarkan putusan pengadilan)
 - 4) Dalam kasus ini, persetujuan harus diberikan oleh wali, orang tua atau kuasa hukum yang sah
 - b. Orang yang tidak memiliki hubungan hukum atau keluarga dengan pasien
 - 1) Teman, tetangga, rekan kerja atau kenalan pasien yang tidak memiliki surat kuasa atau status hukum sebagai wali.
 - 2) Orang yang hanya mendampingi pasien tanpa penunjukan resmi
 - c. Orang yang memiliki konflik kepentingan langsung
 - 1) Memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang dapat mempengaruhi keputusan (misalnya pihak asuransi, pemberi kerja atau pihak luar rumah sakit yang berkepentingan terhadap hasil tindakan medis)
 - 2) Tidak dapat bertindak objektif untuk kepentingan pasien.
 - d. Tenaga Kesehatan yang melakukan tindakan medis tersebut
 - 1) Dokter, perawat atau tenaga Kesehatan yang melakukan tindakan tidak boleh menjadi pemberi persetujuan atas nama pasien.
 - 2) Mereka juga tidak boleh menjadi saksi Tunggal (harus disertai saksi netral jika pasien memberikan persetujuan secara lisan)
 - e. Anak dibawah umur

-
- 1) Anak belum menikah dan berusia dibawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuan tindakan medis untuk dirinya sendiri, kecuali dalam keadaan gawat darurat dan tidak ada wali/keluarga, dokter dapat mengambil tindakan penyelamatan jiwa sesuai kewenangan medis dengan dokumentasi lengkap

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Hak Pasien dan Keluarga disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan yang bermutu, aman, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Seluruh staf wajib memahami dan melaksanakan pedoman ini untuk menjamin terpenuhinya hak pasien secara menyeluruh.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep